

ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΑ (ΑΣΠΙΡΙΝΗ)

Γενικά: Σε οξεία τοξίκωση ($25\text{-}35\text{ mg}/100\text{ ml}$ πλάσματος), τα σαλικυλικά απομονώνουν την οξειδωτική φωσφορυλίωση και αναστέλλουν τον κύκλο του Krebs εμποδίζοντας τον αερόβιο μεταβολισμό, διαταράσσουν τον μεταβολισμό των υδατανθράκων, ασκούν άμεση επίδραση στο ΚΝΣ, διαταράσσουν τη νεφρική αποβολή καλίου, καθώς και την οξεοβασική ισορροπία.

Ιστορικό: Ελέγχουμε το χρόνο που παρήλθε από τη λήψη της ουσίας, τη ληφθείσα ποσότητα (σημ: η φαρμακοκινητική των σαλικυλικών είναι δόσοεξαρτώμενη), εάν πρόκειται για δισκία γαστροδιαλυτά ή εντεροδιαλυτά ή αν πρόκειται για έλαιο της Γωλθερίας (*oil of Wintergreen*).

Κλινική εικόνα: Ελέγχουμε επισταμένως τα κλινικά σημεία με τα οποία προσέρχεται ο ασθενής στο ιατρείο. Πρέπει να τονιστεί ότι αρχικά (ιδίως σε ενήλικες) μπορεί να εμφανιστεί αναπνευστική αλκάλωση, η οποία στη συνέχεια δίνει τη θέση της σε μεταβολική οξέωση.

Επί μέσης ή/και βαριάς μορφής δηλητηρίαση, εμφανίζονται: υπέρπνοια, εμβοές των ώτων, υπερπυρεξία, εφίδρωση με συνέπεια αφυδάτωση, αρρυθμίες, διαταραχές πήξεως, ληθαργική κατάσταση, ενώ μπορεί να ακολουθήσει υπερδιέγερση, τρομώδεις παραλήρημα, σπασμοί, κυάνωση, oligουρία, πνευμονικό οίδημα, αναπνευστική καταστολή και κόμα ή θάνατος.

Αν πρόκειται για παιδί, η θανατηφόρος δόση μπορεί να είναι και στα **75-150 mg/kg ΒΣ**, ήτοι περίπου **6 δισκία Ασπιρίνης** ή **5 ml Wintergreen oil**, ενώ ένδειξη βαριάς τοξίκωσης αποτελεί η εμφάνιση πυρετού, η αφυδάτωση και η οξεία νεφρική βλάβη (*ολιγουρία/ανουρία*).

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Προτεραιότητα (ειδικά στον κωματώδη ασθενή) είναι η εξασφάλιση του αεραγωγού (Α), η επαρκής οξυγόνωση (Β) και η κυκλοφορική υποστήριξη (C). Ελέγχουμε διαρκώς τα ζωτικά σημεία του ασθενή, τον καρδιακό ρυθμό (*ΗΚΓ/HR*), την αναπνευστική συχνότητα (*RR*) και τον κορεσμό οξυγόνου (*SpO₂*), το επίπεδο συνείδησης με την GCS ή AVPU.
2. Χορηγείται O₂ στα 6-12 lt/min, με απλή μάσκα ή Venturi, για υποβοήθηση της αναπνοής.
3. Χορηγείται **σιρόπι Ιπεκακουάνας** (Ipecanom 2x15 ml) για την πρόκληση εμέτου, εφόσον δεν υπάρχει διαταραχή της αναπνευστικής λειτουργίας και του επιπέδου συνείδησης.
4. Επιχειρείται, επίσης, έκπλυση στομάχου (*μέσα σε 4-6 ώρες από τη λήψη*) και στη συνέχεια χορηγείται **ενεργός άνθρακας** (fl. 250 ml Toxicarb) μέσω ρινογαστρικού σωλήνα Levin, υπό την προϋπόθεση ότι η αναπνευστική λειτουργία και η GCS κρίνονται ικανοποιητικές.
5. Αν η δηλητηρίαση αφορά σε εντεροδιαλυτά δισκία (*Salospir*), τότε η απομάκρυνσή τους με πλύση στομάχου επιχειρείται με την παράλληλη έκπλυση με διττανθρακικό νάτριο 1%.
6. Τοποθετούμε καθετήρα Foley 14-16 fr, για τη λεπτομερή παρακολούθηση της διούρησης.
7. Χορηγούνται ενδοφλεβίως **κρυσταλλοειδή** (N/S ή R/S), σε δόση 400 ml/m^2 επιφανείας σώματος, για βελτίωση της ιστικής υποάρδευσης, της αφυδάτωσης και της υποογκαιμίας. Η συνολική χορήγηση κρυσταλλοειδών υγρών μπορεί να φτάσει έως τα $3\text{ lt/m}^2/24\text{h}$.
8. Επίσης, χορηγούμε αρχικά 100 ml **Διττανθρακικά [NaHCO₃] 4%**, εντός 30-40 λεπτών και εν συνεχεία χορηγούμε διάλυμα 1000 ml D₅W με 3 amp. NaHCO₃, εντός 4-6 ωρών. (Σημ: *Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για πιθανή επιδείνωση υπάρχουσας υποκαλιαιμίας*).
9. Χορηγείται Φουροσεμίδα (2-5 amp. Lasix) σε 250-500 ml N/S (*στάγδην, αναλόγως ΑΠ*) για να αποφύγουμε πνευμονικό ή εγκεφαλικό οίδημα από υπερφόρτωση υγρών, αλλιώς για τον ίδιο σκοπό χορηγούμε Μαννιτόλη 20%, βραδέως ενδοφλεβίως με ρυθμό 5 mg/kg.
10. Επί αιματέμεσης ή εμφάνισης σοβαρών αιμορραγιών από τους βλεννογόνους, χορηγείται **Βιταμίνη Κ** (ήτοι: $\frac{1}{2}$ - 1 amp. Konakion 10 mg) ενδομυϊκώς ή πολύ βραδέως ενδοφλεβίως.
11. Επικοινωνούμε με το οικείο νοσοκομείο για να ενημερώσουμε για το περιστατικό που αντιμετωπίζουμε και το οποίο πρόκειται να διακομίσουμε, ώστε να ενημερωθεί εγκαίρως η Αιμοδοσία και το ΤΕΠ για την εξασφάλιση νωπού αίματος και αιμοπεταλίων ή/και FFP.